



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رباب عبد الحميد محمد حجازي

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : بولاق الدكرور العنوان : 0

رقم البطاقة : 27709140104621 رقم التليفون : 01001908195 تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 14-09-1977 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : جراحات أورام تدخل جراحی لاستئصال كامل /تحفظى للثدى +تفريغ قسم العلاج : الغدد الليمفاوية و/ او الغدد الحارسة [13155]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / أ.د. / أ.د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رباب عبد الحميد محمد حجازي National ID: 27709140104621	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

Mastectomy or breast-conserving surgery with axillary lymph node dissection and/or sentinel lymph node biopsy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

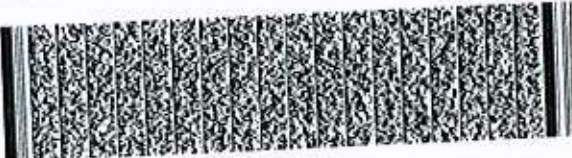

 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية

رباب
 عبدالحميد محمد حجازي
 ٧٦ المساكن امامب ٢٠ امام مسجد قباء
 بولاق الذكور - الجيزة

١٩٧٧/٠٩/١٤ ٢٧٧ ٠٩ ١٤ ٠١ ٠٤٦ ٢١
 I12391959


 ٢٠٢٠/٠١ ٢٧٧/٩١٤٠١٠٤٦٢١
 حاصلة على بكالوريوس معروض
 أنثى مسلمة
 رضا فهمي مبد حسن
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠١/١٩


 ١



05/18/2026

MDT FORM

Name: <u>روبة صالح بن محمد</u>	MRN: <u>10453</u>
Age: <u>49 Y</u>	ID: <u>27709140104621</u>
Menopausal Status: <u>Premenopausal</u>	Phone: <u>01001908195</u>
NRS SCORE: <u></u>	Marital Status: <u>married</u>
BMI: <u></u>	Family History: <u>-ve</u>
CO Morbidity: <u>DM on Glucosephage</u>	Reason Of MDT: <u>New case</u>

Clinical Data:

BX: <u>IDC</u>	R	L
ER <u>8/8</u> PR <u>8/8</u> HER <u>2+ diff</u> KI67 <u>30%</u>		
Sonomammography:		
Mets Workup:		
History:		
47 yrs old female pt. , premenopausal. , DM. , condition started with Lt breast mass detection at 9/2025 , neglected , 3/2026 BSM revealed Lt breast mass 17*14mm , IDC , G1 , ER 8/8 , PR 8/8 , HER2 2+ , +ve by SISH , KI67 30%. Last MDT 29/4/2026. .1.Revision of IHC. ,ER, PR.		
Recommendations:		
US & biopsy revealed fibroadenosis MRI brain free		
MDT Outcome & Plan		
In view of having cT2 N0 disease, for: 1.Clip insertion in bilateral masses 2.Portacath insertion 3.start NACT :Taxol weekly x12/Herceptin/Perjeta then assessment of response to go for Lt WLE &		

T N M

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
<u>Dr. Ahmed Al-Faraj</u>					

Patient Name : الأستاذ / رباب عبد الحميد محمد	Request No. : 13006170
Patient No. : 27709140104621	Request Date : 28/04/2026
Path No. : SR-514/26	Verification Date : 16/05/2026
Sex : Female	Financial Category : جوسفات روسي - نفقة الدولة
Age : 48 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast 11-12 O'clock mass (BIRADs 4c).
Nature of specimen: Referred block & slides (Tru-cut biopsy).

Gross examination:

One referred block & six referred slides were received labelled by (943/26), including one (H&E) stained slide and five IHC slides for (ER, PR, HER2, SISH & Ki67).

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- * Ductal carcinoma in situ: Absent.
- * Perineural invasion: Absent.
- * Angioinvasion: Absent.
- * Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

IPT :

- ER: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Intermediate complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- SISH: Amplified with small clusters.
- Ki67: 25%.

Diagnosis:

Left breast mass, Referred block & slides (Tru-cut biopsy):
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed



Patient Name : الأستاذ / رباب عبد الحميد محمد	Request No. : 13006170
Patient No. : 27709140104621	Request Date : 28/04/2026
Path No. : SR-514/26	Verification Date : 16/05/2026
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age : 48 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Amplified with small clusters.
- Ki67: 25%.

* Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%

and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+(Ultra-low): as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of

the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 16/05/2026 12:03:26

Page 2 of 3

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



RMS
10.202

Name: Rabab Abdelhamid Mohamed
Referred by: Prof.

Date: 25/4/2026
ID: 30209789

F18-FDG PET/CT STUDY

Clinical History:

- Left breast invasive duct carcinoma for initial assessment.

Technique:

- Radiopharmaceutical: 18F FDG.
- PET/CT images were acquired from the skull base through the upper thighs & CT images were acquired for the purpose of anatomical localization and attenuation correction. Images were reviewed in the transaxial, coronal, and sagittal planes.
- Additional notes: SUV max normalized to body weight was used.

COMPARISON: No previous PET CT studies.

FINDINGS:

Head and Neck:

- No hyper-metabolic FDG avid cervical LNDs
- No FDG avid thyroid nodules
- Physiologic FDG uptake is seen in the oropharynx, salivary glands, and larynx.
- Ill-defined relative increased FDG uptake at left parietal region, for better MRI assessment.





Chest:

- Left breast FDG avid UIQ speculated mass measures 2x2x2cm of SUVmax~11.4.
- Bilateral few small sized non-FDG avid axillary LNs, with preserved fatty hila
- There is no hypermetabolic mediastinal lymphadenopathy.
- NO FDG avid lung nodules or masses detected.
- No metabolically active pericardial or pleural lesions detected.
- Physiologic FDG uptake is noted in the heart.

Abdomen and Pelvis:

- There is no hypermetabolic abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- The liver is average size and homogenous parenchymatous texture with NO FDG avid focal lesions detected.
- The spleen is of average size with NO FDG avid focal lesions detected.
- The pancreas shows normal FDG avidity.
- There are no active adrenal nodules.
- Physiologic FDG excretion is seen in the kidneys and bladder

Musculoskeletal:

- Normal FDG activity is seen over the axial skeleton. No focal active blastic or lytic bone lesions detected.





مؤسسة مستشفى سرطان
الأطفال - مصر
Children's Cancer Hospital
Foundation - Egypt

Nuclear Medicine Dept.
PET/CT Unit

IMPRESSION:

- FDG avid left breast UIQ speculated neoplastic mass as described.
- Ill-defined relative increased FDG uptake at left parietal region, for better MRI assessment.

Thanks for referral,

Eman Moussa, MD
Radiology Consultant

Esraa Roshdy, MD
Nuclear Medicine Consultant

1 Seket Al-Emam st, El Sayda Zainab, Cairo
P.O. Box: 1 El Dawawin, Egypt
Tel: (202) 19057
Fax: (202) 25 35 1745
E-mail: info@57357.org



جمعية أطفال السرطان
الأمريكية ضد السرطان
American Pediatric Cancer Society



Egypt
Cancer Network
USA



Egypt
Cancer Network
Canada



Egypt
Cancer Network
Syria

شارع سكة الإمام - السيدة زينب - القاهرة
ص. ب : الدواوين - مصر
الهاتف : (202) 19057
فاكس : (202) 25 35 1745
57357Egypt

[[DOCTYPE:PET_SCAN]]



Patient Name:	Rabab Abdelhaimed Mohamed Hegazy	Exam Date:	5/2/2026
Patient ID:	30209789	Accession:	MR260004857
Date Of Birth:	9/14/1977	Procedure:	MRI Brain w/ Contrast
Gender:	F		
Age:	48Y 7M		

Multiple Studies Reported:

Accession: MR260004857, Date: 5/2/2026, Procedure: MRI Brain w/ Contrast

Accession: MR260004856, Date: 5/2/2026, Procedure: MRI Cervical Spine w/o Contrast

MRI EXAMINATION OF THE BRAIN

Clinical History:

Breast cancer

MRI Findings:

- * Normal size shape & position of the cerebral ventricles with no midline shift or deformity.
- * Normal gray-white matter interface with no areas of abnormal signal intensity.
- * No evidences of mass lesions.
- * No areas of abnormal enhancement are seen at the post contrast scan.
- * No gross vascular abnormality.
- * Normal cerebellum, brain stem & cervico – medullary junction.
- * Normal sellar region.
- * Normal extra axial spaces.

Opinion:

- * Normal contrast enhanced MRI study of the brain.

MRI STUDY OF THE CERVICAL SPINE

MRI Findings:



Patient Name:	Rabab Abdelhaimed Mohamed Hegazy	Exam Date:	5/2/2026
Patient ID:	30209789	Accession:	MR260004857
Date Of Birth:	9/14/1977	Procedure:	MRI Brain w/ Contrast
Gender:	F		
Age:	48Y 7M		

- Straightened cervical curve
- Normal dimensions of the cervical spinal canal.
- Cervical spondylodegenerative changes manifested by varying grades of reduced height and bright T2 signal of the cervical discs with marginal osteophytic lippings and mild subchondral degenerative signal of their opposing vertebral end plates.
- C4/5, C5/6 and C6-7 posterior and right posterolateral disc bulges seen compressing the spinal cord ventrally and encroaching on the exit neural foramina
- Normal size and signal intensity of the cervical spinal cord and cervicomedullary junction.
- No paraspinal soft tissue lesions.

Opinion:

- Cervical spondylodegenerative changes with multiple disc protrusions as described.

Dr. Mostafa Hussein MD

Her-2 gene: Amplified (Her2/Chr17 =2.3 and average Her2 copy number is 4.3).

Final Result #1

Amplified

Site 2

Signature

SAFY HOSNY AHMED

Co-Signed by:

Dr. Marwa Mahmoud Abd Elkader, FEBP, IFCAP



Reported and electronically endorsed by

Marwa Mahmoud Abdelkader Nada

Pathology lab director:

Dr. Hazem Abdelazim, MD, IFCAP

Validated on 19/04/2026 09:59 PM

Print Date:

21/04/2026 01:27 PM

Page Number: 2 of 2



www.Baheya.org



16602

Mammogram

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]



مؤسسة مستشفى سرطان
الأطفال - مصر
Children's Cancer Hospital
Foundation - Egypt



Patient Name:	Rabab Abdelhalmed Mohamed Hegazy	Exam Date:	5/2/2026
Patient ID:	30209789	Accession:	MR260004857
Date Of Birth:	9/14/1977	Procedure:	MRI Brain w/ Contrast
Gender:	F		
Age:	48Y 7M		

Dr Mohamed Khalaf, MD

Final Report by: Samia Yehia

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

بشأن تقرير طبي للمريض:

إيماء للطلاب المقدم من

رقم طبي

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الخروج

تاريخ وساعة الدخول

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

التهال عظمي بالسرير
للحجم والعضلانية كالمعتاد
H wt + s1NB.
بدون معاملة خاصة بالسرير

تحريراً في

/ / التاريخ:

الوقت:

الطبيب المعالج

يتمتع

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

بشأن تقرير طبي للمريض:

إيماء الطالب المقدم من

رقم طبي

نشر ف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الخروج

تاريخ وساعة الدخول

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

المستشفى (جوستاف روستافي)
بمقره مستشفى الملك فيصل
Rt-wlf

تحريرا في

/ / التاريخ :

الوقت:

الطبيب المعالج

يعتقد ،،

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

بشأن تقرير طبي للمريض:

إيماء الطالب المقدم من

رقم طبي

نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الخروج

تاريخ وساعة الدخول

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

كولت - الـ مريض عن لـ
للـ

تحريراً في

التاريخ: / /

الوقت:

الطبيب المعالج

يتم

Patient ID: 96195	Patient Name English: Rabab Abdalhamid Mohamed Hegazi
المرضى رقم: 96195	2026/06/10 11:24:41 AM :Report Date

Ultrasound Guided clip insertion:

Clinical summary: Pathologically proven Left breast invasive ductal carcinoma grade II (+ve ER, +ve PR, equivocal HER2 and Ki67= 25 %) and right breast probably benign lesion (BIRADS 3) for clip insertion.

Technique:

LEFT BREAST:

- Under complete sterile conditions, 3ml of local anaesthetic were administered at the site of concern of the Left breast.
- One metallic clip is inserted within the center of malignant mass lesion located at UIQ at 10 o'clock position.
- This was confirmed by mammography CC & ML views.

RIGHT BREAST:

- Under complete sterile conditions, 3ml of local anaesthetic were administered at the site of concern of the Left breast.
- One metallic clip is inserted within the center of the mass lesion located at UOQ 10 o'clock position.
- This was confirmed by mammography CC & ML views.

Best Regards
Dr. Marwa Hassan

Patient's Name:

Rabab Abdul Hamid Mohammed Hegazy

Date:

2026-09-09

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: follow up after NACT for left breast cancer.

Findings:

Left breast:

- Preserved fibroglandular pattern.
- Replacement of the pathologically proved 11 o'clock, zone 2 mass with granulation tissue and fibrosis with clip inside .
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non specific axillary lymph nodes .

Right breast:

- Preserved fibroglandular pattern.
- The previously described right 3 ,7 and 10 o'clock positions seem to be fat entrapment rather than being fibroadenomas .
- No solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Left breast (BIRADS 6): complete radiological response of the UIQ malignant mass .

Right breast (BIRADS 2): Benign lesions.

Prof.MONA ZAKY